

--

Name: ماجده عبد العزيز محمد عبد اللطيف National ID: 26211252101887	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



١١٤٧.٢٣٩٢
١١٤٥١٧٣٤٣٩



Patient Name	: الأستاذ / ماجده عبدالعزيز محمد عبداللطيف	Request No.	: 13006093
Patient No.	: 26211252101887	Request Date	: 5/11/2025
Path No.	: 2276/25	Verification Date	: 9/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Molecular Testing Report

Clinical Data: Metastatic adenocarcinoma of GIT origin
Nature of specimen: Tru cut biopsy.

Gross Examination:

Paraffin block received by Inter Mark. H&E stained slide is prepared, examined by pathologist and confirmed that block contains tumor matching with the requested test

• **Test(s) requested:** KRAS, NRAS and BRAF Gene, Mutation testing.

Methodology and Limitations:

Method Limitation: The designed primers used in this method and the analysis pipeline are capable of detecting KRAS codons 12, 13, 60, 61, 117 and 146, NRAS codons 12, 13, 60, 61 and 146, and BRAF codon V600E mutations only.

Limit of detection:

- Sensitivity of KRAS-G12D, KRAS-G12A, KRAS-G12V, KRAS-G12S, KRAS-G12R, KRAS-G12C, KRAS-G13D, KRAS-G13C, KRAS-Q61L, KRAS-A146, NRAS-G12D, NRAS-G12S, NRAS-G13D, NRAS-G13R, NRAS-G12C, NRAS-G12V, NRAS-G12A, NRAS-G13V, NRAS-Q61L, NRAS-Q61H and NRAS-K117N mutations are 1% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.
- Sensitivity of KRAS-Q61R, KRAS-Q61H, NRAS-Q61R, NRAS-Q61K & NRAS-A146T mutations are 2% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.
- Sensitivity of KRAS-K117N, KRAS-A146T, KRAS-A146V and BRAF V600E mutations are 5% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.

Indication: Predictive test for response to therapy.

Gene	Result	Mutation Detected
KRAS	Mutant	Mutation detected in Exon 2
NRAS	Not Tested	---
BRAF	Not Tested	---

Printing Date : 30/09/2025 11:44:40

Page 1 of 2

Printed By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: ماجده عبدالعزيز محمد		
MR. : 9173		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 63-year-old individual with a history of synchronous breast and colon cancers. Initial staging in 2020 documented a T2N1 breast carcinoma (ER 8/8, PR 6/8, HER2-negative) treated with right mastectomy, axillary node dissection (1/12 nodes positive), adjuvant radiotherapy, and 2 years of tamoxifen. In 2024, the patient commenced fulvestrant (FEMARA) and continued through 6 2025. A triphasic CT in 2026 revealed a 10 × 9 × 15 cm HFL mass and a 15 × 11 × 15 cm rectosigmoid lesion, consistent with metastatic adenocarcinoma of upper GI origin. Molecular testing identified a KRAS exon 2 mutation; NRAS and BRAF were not tested. The patient received five cycles of XELOX (capecitabine/oxaliplatin) with a dose of 130 mg/m² oxaliplatin. Subsequent imaging on 7 Feb 2026 showed no change in the HFL mass but noted peritoneal nodules; the MDT recommended adding bevacizumab to XELOX for the next cycle. On 14 May 2026, the MDT approved bevacizumab with XELOX for cycle 8, prescribing oxaliplatin 200 mg/m² (weight 60 kg, height 160 cm, SA 1.6) and fulvestrant. On 3 Jun 2026, due to rectal bleeding, bevacizumab was postponed for cycle 9, and the regimen was adjusted to XELOX, oxaliplatin 200 mg/m², fulvestrant, calcium, and vitamin D. A CT on 13 Jun 2026 reported progression in the liver and rectosigmoid mass, with new lung nodules; the MDT discussed fulvestrant and supportive care. On 8 Aug 2026, an MDT evaluated transvaginal ultrasound findings of uterine lesions; FOLFIRI with bevacizumab was considered, but bevacizumab approval was pending. A port-catheter was planned for cycle 1 day 1 of FOLFIRI. On 26 Aug 2026, the patient was evaluated for possible surgical intervention for intussusception and uterine lesions; due to lack of bevacizumab approval, the plan was to shift to FOLFIRI-bevacizumab for cycle 1 day 15, with a 10 % dose reduction of FOLFIRI because of vomiting. A pharmacy note on 26 Aug 2026 documented a hemoglobin of 7.4 g/dL (post-transfusion), bilirubin 1.9 mg/dL, and a 25 % dose reduction of camptothecin. On 9 Sep 2026, the patient experienced diarrhea and fatigue during cycle 2 day 1 of FOLFIRI, receiving camptothecin 228 mg, levamisole 510 mg, and a total FOLFIRI infusion of 3072 mg, with concurrent fulvestrant, calcium, and vitamin D. The patient has completed 2 cycles of FOLFIRI.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	19-09-2026 التاريخ :
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name	: الأستاذ / ماجده عبدالعزيز محمد عبداللطيف	Request No.	: 13006093
Patient No.	: 26211252101887	Request Date	: 5/11/2025
Path No.	: 2276/25	Verification Date	: 9/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Molecular Testing Report

Interpretation & Comment

Based on the current results This patient should not be considered for anti-EGFR monoclonal antibody targeted therapy because as per the NCCN guidelines Colorectal tumors with any known KRAS mutation (exon 2, 3, 4) or NRAS mutation (exon 2, 3, 4) are associated with lack of clinical response to anti-EGFR.

Test Background

Approximately 40% of patients with mCRC harbor an activating KRAS & NRAS mutations in 4% of the patients. The outcome of patients with RAS mutations is worse compared to RAS wild type (RAS wt) cases. However, KRAS & NRAS mutations also have distinct impacts on survival in mCRC; the prognosis of the aggressive NRAS mutant molecular subset is poor.

According to National Comprehensive Cancer Network guidelines (NCCN; Version 1.2020) for metastatic colorectal cancer (mCCR), expanded RAS panel for activating mutation of KRAS & NRAS is crucial at time of diagnosis to select the patients who are likely to benefit from anti-EGFR therapies.

Test Description

- Tissue sections were reviewed by a pathologist and relevant tumor was selected for analysis.
- DNA was isolated and amplified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) using NRAS and KRAS CE-IVD kits according to manufacture protocol. results interpreted according to the manufacture user guide. Mutation nomenclature was performed considering the following reference sequences: NM_004985.4 (KRAS) and NM_002524.4 (NRAS gene).
- BRAF V600E mutation specific Competitive allele specific TaqMan assay along with its reference wildtype assay were performed for each sample to accurately interpret the results.

Disclaimer:

- The molecular testing reported herein was performed at an external reference lab (57357 molecular laboratory).

Signature

Prof. Dr. Maha Guimei



Medical No. : 10296

Patient's Name: Magda Abdul Aziz Mohammed

Date: 2026-09-23

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Color Duplex scanning of the port-A-Cath revealed: -

- o Port-A-Cath is seen introduced through the left IJV identified by two echogenic lines
- o The left IJV is mildly dilated partially compressible showing adherent echogenic thrombus attached to its anterior wall consistent with subacute partial thrombosis
- o The port-A-Cath pocket is seen at the right infra clavicular region with no related collection or hematoma.

DR: Nermeen Ramadan.MD

Blood Transfusion Monitoring Form

Pa	الرقم الطبي:	9173
MI	اسم المريض:	ماخو عبدالعزير / محمد
	تاريخ الميلاد:	25/11/1962
	الرقم الطبي القديم:	null

Date of delivery: 26/8/2025 Time of delivery: 1:12 Transfusion start time: 12:45 End Time: ...

Blood Group & RH Type: O Type of blood unit: O Blood unit No: ...

Blood unit double checking:	☒ Assigned nurse	Name & ID: Signature: <i>Mona Asada</i>	☒ Charge Nurse	Name & ID: Signature: <i>Aziza</i>
Patient identification double checking (bedside):	☒ Assigned nurse	Name & ID: Signature: <i>Mona Asada</i>	☒ Charge Nurse	Name & ID: Signature: <i>Aziza</i>

Nursing Observation: ☒ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)

If reaction, Notified to: Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	12:45	35.5	95	98	17	140/60	0
After 5 minutes	12:50	35.5	98	97	17	114/65	0
After 10 minutes	1:00	35.2	97	98	17	121/75	0
After 15 minutes	1:15	35.1	98	97	17	121/65	0
After 30 minutes	1:30	35.0	97	98	17	116/75	0
After 45 minutes	1:45	35.5	98	97	17	126/78	0
After 60 minutes	2:00	35.2	97	98	17	110/65	0
After 90 minutes	2:30	36.2	98	97	17	120/70	0
After completion of transfusion	2:30	36.2	98	97	17	110/60	0
After 5 minutes from completion of transfusion	2:35	35.9	98	98	17	120/75	0
After 1 hour from completion of transfusion	3:35	36.2	98	97	17	110/60	0
After 2 hours from completion of transfusion	4:35	36.2	98	97	16	125/70	0

Nurse Name & ID: *Mona Asada* Signature: Date: 26/8/2025 Time:
* Use separate form for each unit transfused.

Diet Type: *Vegetarian*[illegible]

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.

**This form is NOT intended for use for medications orders.*

Blood / Blood Components Transfusion Consent

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

الرقم الطبي:	9173
مأخذه عند المبرر / محدد:	اسم المريض:
تاريخ الميلاد:	25/11/1962
الرقم الطبي القديم:	null

اقرر انا الموقع ادناه المريض / ممثل القانوني / أحمد عبدالبر / جواز سفر SA.11.921.1.1.8.8 رقم قومي / جواز سفر SA.11.921.1.1.8.8 التشخيص:

الرقم الطبي: التشخيص:

اني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته وذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح ومفهوم:

١- سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب

الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتصاقات أو

فشل الكبد.

٢- القوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣- المخاطر والمضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ- ردود الفعل التحسسية والتي قد تشمل قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بأمراض فيروسية و بكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة قائلن السوائل أو التحسس الشديد، تتفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن

حدث في القلب أو الكبد.

و- إصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم إن وجدت.

٥- حقن في طح الإسفلة والحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقرر انا الموقع ادناه باني على كامل المعرفة والفهم لكل مشتقات هذا الاقرار واتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما فيه

اسم المريض (أو ممثله القانوني): أحمد عبدالبر اسم الطبيب المعالج / الرقم الوظيفي: SA.11.921.1.1.8.8

درجة القرابة: التوقيع: أحمد عبدالبر

رقم قومي / جواز سفر: SA.11.921.1.1.8.8 التاريخ/ الوقت: 25/11/2025

التوقيع: أحمد عبدالبر

اسم الشاهد: أحمد عبدالبر

التاريخ/ الوقت: 25/11/2025

رقم قومي / جواز سفر: SA.11.921.1.1.8.8

التوقيع: أحمد عبدالبر



Blood Delivery form

Patient name:	ماجدة عبدالرزاق محمد
MRN:	5446/2020

نقطة دولة نفدي

Components	Amount	Order Status	Time of Order
☐ Whole blood		☐ Scheduled	
☐ Packed RBCs		☐ Emergency	
☐ Filtered Packed RBCs		☐ High Emergency (without tcross matching)	
☐ Irradiated Packed RBCs	One Unit	☐	
☐ Fresh Frozen Plasma		☐	
☐ Platelet concentrate		☐	
☐ Cryo precipitate		☐	
☐ Irradiated Platelet		☐	

Time of Delivery of Blood

12:28:11 P

Components:

Blood Group:

(O)

RH Group (D antigen):

Positive

Antibody Screening:

Cross Matching:

Matched

Bag No.:

2614

A3970258

Donation time

EXPIRATION DATE

11/8/2026

15/9/2026

Donation time

EXPIRATION DATE

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	26-2026 أغسطس	12:28 P

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
Amr Mohamed	Amr Mohamed	26-2026 أغسطس	12:28 P

26211752101887

Patient Name:
MRN:

Blood / Blood Components Request

Room no: 2621	Sex: ☐ Male ☒ Female	Age: 64
Diagnosis: 110		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion: ☒ No ☐ Yes		To be delivered to: ☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
History of Previous Blood Transfusion Reaction: ☒ No ☐ Yes, specify.....		
Number of Units Needed: ☐ Whole Blood..... Units ☒ Packed Cells..... Units ☐ Platelets..... Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: Units		
Urgency: ☐ Immediate: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ Urgent: Cross matching tests take 1 hour ☐ Routine: compatibility test take two hours		Frequency of Transfusion:
Requesting Physician Name & ID: <i>St. newby</i>	Signature: <i>[Signature]</i>	Date: <i>11/20/16</i>
Sample taken by (nurse) Name & ID: <i>11/20/16</i>	Signature: <i>[Signature]</i>	Date: <i>11/20/16</i>

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature
26-8	OPes	2614	11:16	11/20/16	11/20/16